DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: FABIOLA GRAJALES **Identificación** CC 29868582
Edad: 82 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: QUIROFANO 3 **Fecha programación de cirugía:** 02/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**468011**	**REDUCCION INTESTINAL SIN RESECCION INTESTINAL VIA ABIERTA**	Y39	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**471102**	**APENDICECTOMIA VIA ABIERTA**	Y38	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**530301**	**HERNIORRAFIA INGUINAL ENCARCELADA VIA ABIERTA**	Y38	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**540013**	**DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA ABIERTA**	Y39	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**544104**	**OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA**	Y40	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**867001**	**COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL HASTA DE DOS CENTIMETROS CUADRA DOS**	Y38	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ESP34 DAVID MARTINEZ **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

468011 **REDUCCION INTESTINAL SIN RESECCION INTESTINAL VIA ABIERTA**
471102 **APENDICECTOMIA VIA ABIERTA**
530301 **HERNIORRAFIA INGUINAL ENCARCELADA VIA ABIERTA**
540013 **DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA ABIERTA**
544104 **OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA**
867001 **COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL HASTA DE DOS CENTIMETROS CUADRA DOS**

Dx Preoperatorio: K566 OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS

Dx Postoperatorio: K403 HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA CON OBSTRUCCION SIN GANGRENA

Tipo de Herida: LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 02/11/26 **Fecha Final** 02/11/26
Hora Inicio 11:00:00 **Hora Final** 11:38:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
CONSENTIMIMENTO INFORMADO, PAUSA DE SEGURIDAD.
ANESTESIA GENERAL, ASEPSIA Y ANTISEPSIA, SE COLOCA CAMPOS QUIRURGICOS.
INCISION EN LINEA MEDIA, DISECCION POR PLANOS A CAVIDAD ABDOMINAL.
SE ENCUENTRA LO DESCRITO EN HALLAZGOS.
ASAS DE INTESTINO DELGADO Y SEGMENTO DE EPIPLON MAYOR ATRAOPADO EN SACO HENRIOA Y ANILLO HERNIARIO.
SE REALIZA DISECCION ROMA EN SACO HERNIARIO Y ANILLO HERNIARIO, CON EL FIN DE LIBERAR SEGMENTO DE EXTRUCTURAS ATRAPADFAS.
SE LIBERA SEGMENTO INTESTINO DELGADO ATRAPADO, SE LI9BERA SEGMENTO DE EPIPLON ATRAPAPDO.

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

SE LIBERA INTESTINO ATRAPADO, Y SE REDUCE A CAVIDAD ABDOMINAL, PERFUCION DE SEGMENTO DE INTESTINO ATRAPADO, SE VERISFICA VIABILIDAD. NO FUGAS A MANIOBRAS DE VASALVAS DE CONTENIDO IONTESTINAL. NO AMERITA RESECCION.
SE REDUICE SEGMENTO DE EPIPLON ATRAPADO. SE LIBERA A CAVIDAD ABDOMINAL.
SE PROCEDE REALIZAR HERNIORRAFIA INGUINAL TRANSPERITONEAL, , CIERRE DE ANILLO HERNIARIO CON PROLENE 0.
SE VERISFICA INTEGRIDAD DE CIERRE DE ANILLO INGUINAL.
SE OBSERVA SEGMENTO DE EPIPLON LIBVERADO CON CAMBIOS EDEMAPERILESION Y MACERACION, TEJIDO MACERADO , CON CAMBIOS D COLORACION ISQUEMICOS, SIN REPERFUCION ADECUADA, SE PROCEDE A REALIZAR OMENTECTOMIA PARCIAL, DISECCION ,CORTE, LIGDURA DE MUÑONES PROXIMALES CON SEDA 0, VERISFICAINTEGRIDAD DE LIGADIRA.
SE PROCEDE A REALIZAR APENDICECTOMI1 INCIDENTAL, PINZA,LIGA Y CORTA APENDICE CECAL, LIGADURA DEL MUÑON APENDICULAR CON SEDA 0. ELECTROFULGURACION DE MUCOSA DE MUÑON APENDICULAR CON ELECTROCAUTRIO.
PINZA,LIGA Y CORTA MESO APENDICE ,LIGADURA DEL MUÑON CON SEDA 0-
FDRENAJE DE COLECCION INTRA ABDOMINAL, LIQUIDO DE REACCION PERITONEAL.
CONTEO COMPLETO DE COMPRESAS, DOCUMENTADA POR INSTRUMANTADORA Y AUXILIAR DE ENFERMERIA.
SE TALLA COLGAJO LOCAL SIMPLE EN FASCIA DE PARED ABDOMINAL, PARA IDENTIFICAR FASCIA DE MEJORA CALIDAD Y CONSISTENSIA. SE PROCEDE A CIERRE DE PARED ABDOMINAL, PUINTOS CONTINUOS EN FASCIA CON PROLENE 1, VERISFICA INTEGRIDAD.
SE FIJA CICATRIZ UMBILICXAL A FASDCIA CON VIOCRIL 1.
PUNTOS SUBCUTANEO CON VICRIL 1, PUNTOS DE PIEL -INTRADERMICOS CON PROLENE 3/0.
SE COLOCA APOSITOS LIMPIOS SOBRE HERIDA QUIRURGICA, SE FIJA A PIEL CON MICROPORE

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

ASAS DE INTESTINO DELGADA DILADAS, CON EDEMA PERILESIONAL.
LIQUIDO DE REACCION PERITONEAL LIBRE EN CAVIDAD APROXCIMADAMENETE 300 CC .
HERNIA INGUINAL IZQUIERDA INCARCECALDA . SEGMENTO DE INTESTINO DELGADO ATRAPADO ANILLO INGUINAL INTERNO , INTESTINO TRAPADO APROXIMADAMENETE 12 CM, A 280 CM DE LIGAMENTO DE TREIZ.
SEGMENTO DE INTESTINO DELGADO CON CAMBIOS ISQUMICOS , SE LIBERA DE SACO HERNIARIO, ANILLO HERNIARTIO, AATRAPADO, REPERFUCION DE COLOR AFECTADO ALOS 5 SEGUNDOS. SE REALIZAN MANIOBRAS DE VASALVA, NO SE OBSERVA PERFORACION O MICROPERFORACIONES.
SEGMENTO DE EPIPLON MAYOR DE 10 X 15 CM ATRAPAPDO ANILLO HERNIARIO, AL RIBERAR SEGMENTO DE EPIPLON, CAMBIOS MACRACION, EDEMA PERILESIONAL MARACDAODE REALIZA OMENTECETOMIA PARACIAL DE 10 X 10 CM,
HERNIA INGUINAL IZQUIEDA, ANILLO INGUINAL DE APROXIMADAMENETE 2 X 3 CM, CON SACO HERNIARIO 10 X 15 CM.
FASCIA DE PARED ABDOMINAL DELGADA DE MALA CALIDAD,DELGADA, FRIABLE, SE DESGARA CON FACILIDAD A MANIOBRAS DE VASALVA.
SE REALIZA APENDICECTOMIA INCIDENTAL.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐

APENDICE CECAL.

PRODUCTO DE OMENTECTOMIA PARCIAL.

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES131	RUBEN DARIO LIBREROS	ANESTESIOLOGO
MG181	YULI ANDREA CRUZ ARANGO	AYUDANTE



DAVID MARTINEZ

Reg. 502602

CIRUGIA GENERAL

***** FIN DEL REPORTE *****